BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

RIS CHACHAPOYAS

Semana Epidemiológica (del 08 al 14 de marzo de 2026)



DIRECTOR DE LA RIS CHACHAPOYAS
Mg. Clyde Cowan Muñoz Vargas

RESPONSABLE DE SALUD PUBLICA
Lic. Enf. Cesar Alberto Mori Barco

RESPONSABLE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. Enf. Lith Mariela Malqui Zuta

EQUIPO TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGÍA
Téc. Lab. Silvio Camilo Pariachi Cadenas
Téc. Enf. Milagros Montoya Rojas

APOYO OFICINA DE CC.RR.PP.
Téc. Comp. Marco A. Trigoso Chota

SE 10



Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Dirección Regional de Salud | Red Integrada de Salud Chachapoyas

Presentación



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Epidemiología como "el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud".

El mundo actual, cada vez con mayor velocidad está expuestos a la propagación de los riesgos y amenazas de salud pública, como consecuencia de los tiempos de globalización en que vivimos, cada vez con mayor volumen y rapidez en el desplazamiento mundial de personas, incluyendo el fenómeno de la migración internacional. Esto trae como consecuencia la aparición de pandemias con mayor frecuencia, emergencia de nuevas enfermedades y reemergencia de enfermedades.

Nuestro país no es ajeno a este fenómeno, solo en la última década hemos sido testigos de la introducción de enfermedades como chikungunya y zika, la reintroducción del sarampión, transmisión de la viruela de mono, introducción de la pandemia de la COVID-19. Además del reto que significa continuar luchando contra las enfermedades endémicas como dengue, malaria, tuberculosis, VIH/SIDA, carbunco, fiebre amarilla selvática, riesgo de rabia humana y de fiebre amarilla selvática, entre otras.

Estos retos actuales de salud pública, representan un desafío para el sistema de salud del país, que tienen la responsabilidad en desarrollar competencias en epidemiologia y salud pública para hacerles frente.

La Oficina de Epidemiología de Epidemiología, es la Oficina de la Red de Salud Chachapoyas encargada de gestionar de manera eficaz, eficiente y oportuna los procesos de vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria, salud global, respuesta y control de brotes, epidemias y otros eventos de importancia en salud pública.

La Oficina de Epidemiología publica semanalmente el Boletín Epidemiológico cuya información es producto de la notificación de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, Gobiernos regionales, EsSalud, Sanidades de fuerzas armadas y policiales, y privados, que conforman la Red de Unidades notificantes e Informantes de la Red de Salud Chachapoyas, además de información o análisis especializado que desarrolla esta Oficina.

Su finalidad es difundir la situación epidemiológica de las provincias de Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Bongará, la ocurrencia de brotes y/o epidemias para una adecuada y oportuna toma de decisiones en prevención y control en salud pública.



Lic. Enf. Lith Mariela Malqui Zuta
Responsable de Epidemiología
Red de Salud Chachapoyas

Análisis y Situación de Salud

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES:

Situación Epidemiológica de Varicela:

El virus varicela-zóster (VVZ) produce dos formas clínicas, la varicela y el herpes zóster. La varicela es una enfermedad aguda que cursa con fiebre leve o moderada, síntomas generales, luego aparece un exantema macular auto limitado (a veces con compromiso de mucosas o enantema), que rápidamente evoluciona a pápulas, luego a vesículas y finalmente a costras que se desprenden tras una a dos semanas. Generalmente es benigna en la infancia, pero en adultos puede ocasionar neumonía o encefalitis, dejar secuelas permanentes y causar la muerte.

Se transmite de persona a persona desde dos días antes de la aparición de la erupción hasta que desaparecen las vesículas. También puede ser contraída a partir de las lesiones de una persona con herpes zóster. Quienes contraen la enfermedad a partir de otro familiar, suelen presentar formas más graves que los primeros casos, puede ser por un contacto más intenso y continuado con el virus.

La varicela es muy contagiosa, de manera que el 80–90% de quienes conviven la contraen. En países con clima templado, el 90% de la población padece la varicela antes de los 15 años de edad y el 95% antes de llegar a la vida adulta.

En la Red de Salud Chachapoyas, se realiza la Vigilancia Epidemiológica de este daño a través de la Notificación Semanal, como vigilancia de tipo pasiva, es así que hasta la presente Semana Epidemiológica **(SE 10)** del **2026**, se reportó un total de **04 casos de varicela sin complicaciones, siendo los 04 casos autóctonos** con una **IA de 2.32 x 100 000 habitantes.** ***(Ver Tabla N° 01)***

Los casos autóctonos reportados proceden de las Provincias de: Luya (02) y Rodríguez de Mendoza (02), en donde se puede apreciar que las provincias más afectadas por esta enfermedad son la provincia de Luya y Rodriguez de Mendoza; a nivel de distritos; San Nicolás, Lámud, María y Limabamba son los que registran más casos de varicela. ***(Ver Tabla N° 02 y N° 03)***

Según la clasificación clínica el 100% (04/04) de los casos notificados a la presente semana epidemiológica se atribuyen a casos de Varicela sin complicaciones ***(Ver Gráfico N° 01)***

Según curso de vida, el grupo de edad más afectado para esta Semana Epidemiológica **(SE 10)** son los niños de 0 – 11 Años con un 75% (03/04), asimismo los jóvenes de 18 – 29 Años con un 25% (01/04), del total de casos. ***(Ver Gráfico N° 02)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia una disminución de 63.64% (07 casos) en relación a los casos reportados para el mismo periodo del año 2025. ***Ver Gráfico N° 03)***

Según el último decenio se evidencia que en el año 2017 se reportaron la mayor cantidad de casos de varicela, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último decenio. ***(Ver Gráfico N° 04)***

Según el canal endémico por lo notificado en la Semana Epidemiológica **(SE 10)** la ubicación de los casos de varicela es la **Zona de Éxito,** zona que representa el 70% (07/10) del total de semanas epidemiológicas reportadas. ***(Ver Gráfico N° 05)***

Tabla N° 01. Red de Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Varicela y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	2	1	6	2	11	4
IA x 100 Mil Hab.	1.16	0.58	3.47	1.16	6.40	2.32
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

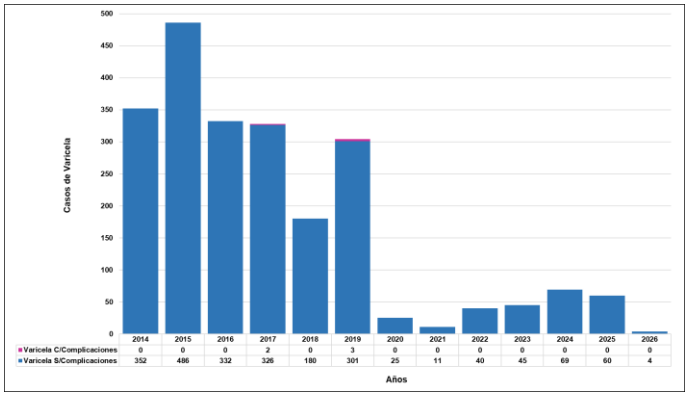
Tabla N° 02 y N° 03. Red Integrada de Salud Chachapoyas, Casos de Varicela, según provincias y distritos. Años 2021– 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	1	3	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0
CHACHAPOYAS	4	9	20	18	37	0	1	1	1	1	3	0
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	3	22	16	16	8	2	1	0	3	0	0	2
RODRIGUEZ DE MENDOZA	3	6	9	35	10	2	0	0	2	1	7	2
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	**11**	**40**	**45**	**69**	**60**	**4**	**2**	**1**	**6**	**2**	**11**	**4**

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
CHUQUIBAMBA	1	1	2	13	20	0	0	0	0	0	0	0
SAN NICOLAS	1	5	6	20	2	1	0	0	1	1	1	1
CHACHAPOYAS	0	5	0	2	12	0	0	0	0	1	2	0
OCUMAL	0	1	3	9	5	0	0	0	1	0	0	0
CONILA	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMUD	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	1
LA JALCA	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARISCAL BENAVIDES	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0
CHILIQUIN	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEIMEBAMBA	2	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0
HUAMBO	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
FLORIDA	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0
LONGAR	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0
OMIA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
VISTA ALEGRE	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
PISUQUIA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
COCABAMBA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIMABAMBA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
SANTA CATALINA	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SANTO TOMAS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLOCO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
SAN FRANCISCO DE YESO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
MONTEVIDEO	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
CAMPORREDONDO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
LONYA CHICO	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JUMBILLA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA ROSA	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
MARIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TINGO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIRIMOTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARISCAL CASTILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JAZAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BALSAS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
INGUILPATA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CHISQUILLA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCALLI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOLINOPAMPA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total general	**11**	**40**	**45**	**69**	**60**	**4**	**2**	**1**	**6**	**2**	**11**	**4**

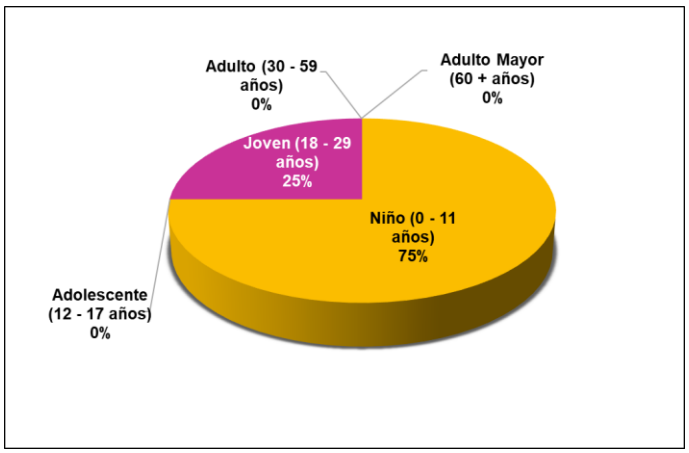
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 01. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Varicela, según tipo de diagnóstico. Años 2014 - 2026*



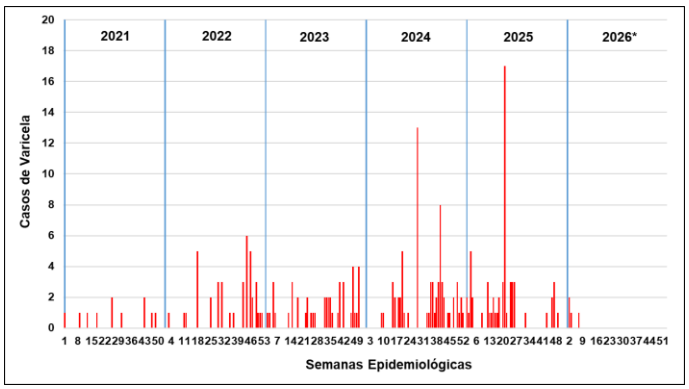
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 02. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Varicela, Según Curso de Vida. Año 2026*



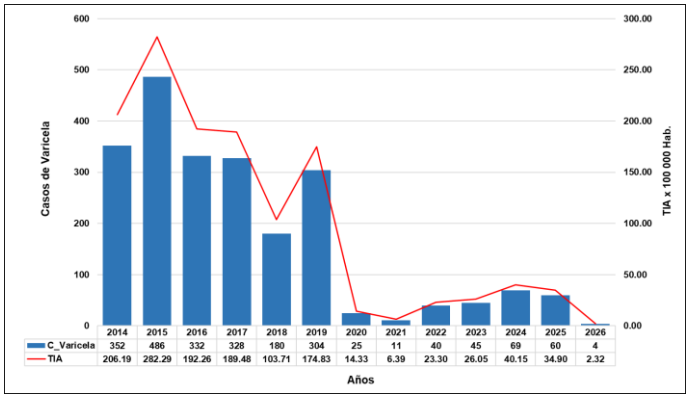
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 03. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de casos de Varicela. Años 2021 - 2026*



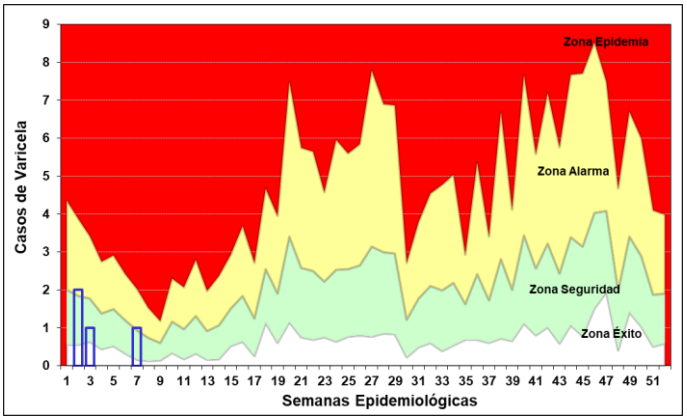
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 04. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Varicela y TIA. Años 2014 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 05. Red de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de Varicela. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

ENFERMEDADES METAXENICAS:

Situación Epidemiológica de Leishmaniosis:

La **leishmaniosis cutánea** es una enfermedad causada por parásitos, transmitidos al ser humano por la picadura de distintas especies de insectos flebótomos.

La **leishmaniosis cutánea** es una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en las zonas rurales. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo de parásito, al medio ambiente y a la respuesta inmune del huésped. El periodo de incubación es variado, va desde las dos semanas hasta varios meses.

Su epidemiología depende de las características de la especie del parásito, las características ecológicas locales de los lugares donde se transmite, la exposición previa y actual de la población humana al parásito y las pautas de comportamiento humano.

Se conocen más de 90 especies de flebotominos transmisores de Leishmania. El principal vector en la Región Amazonas y en la jurisdicción de la Red de Salud Chachapoyas, es la Lutzomya.

La enfermedad se presenta en tres formas principales:

Leishmaniosis visceral, en más del 95% de los casos es mortal si no se trata. Se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. En la Región Amazonas no se han reportado casos de este tipo de leishmaniasis.

Leishmaniosis cutánea, es la forma más frecuente de leishmaniasis, y produce en las zonas expuestas del cuerpo lesiones cutáneas, sobre todo ulcerosas, que dejan cicatrices de por vida y son causa de discapacidad grave.

Leishmaniosis mucocutánea, conduce a la destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta.

En la Red de Salud Chachapoyas hasta la Semana Epidemiológica **(SE 10)**, las unidades notificantes han reportado un total de **17 casos** de leishmaniosis, (C=17), siendo los **17 casos autóctonos** con una **IA de 9.88 x 100 000 habitantes.** ***(Ver Tabla N° 04)***

La provincia que reporta el mayor número de casos de leishmaniasis es la provincia de Chachapoyas con el 64.71% (11/17); teniendo así que los **17 casos** autóctonos proceden de las provincias: Chachapoyas (11), Rodríguez de Mendoza (03), Luya (02) y Bongará (01); a nivel de distritos el más afectado por esta enfermedad es el distrito de La Jalca (06 casos). ***(Ver Tabla N° 05 y N° 06)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia una disminución de 73.85% (48 casos) en relación a los casos reportados para el mismo periodo del año 2025; asimismo, en el último quinquenio se evidencia que la tendencia a lo largo de los años ha venido siendo oscilante, donde la notificación más baja fue en el año 2025 con un total de 157 casos. ***(Ver Gráfico N° 06)*** Según el último decenio se evidencia que en el año 2018 (339 casos) se reportó la mayor cantidad de casos de leishmaniasis, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último decenio. ***(Ver Gráfico N° 07)***

Según la clasificación clínica se evidencia que el 100% (17/17) de los casos notificados corresponden a leishmaniosis cutánea y el 0% (00/00) a leishmaniosis mucocutánea. ***(Ver Gráfico N° 08)***

Según curso de vida, el grupo de edad más afectado para esta Semana Epidemiológica **(SE 10)** son los adultos de 30 – 59 Años con un 41% (07/17), asimismo los niños de 0 – 11 Años, adolescentes de 12 – 17 años y adultos mayores de 60 años a más con un 18% (03/17), del total de casos. ***(Ver Gráfico N° 09)*** El 53% de casos notificados son de sexo masculino (09/17) y el 47% restante son de sexo femenino (08/17). ***(Ver Gráfico N° 10)***

Según el canal endémico se evidencia que para la presente Semana Epidemiológica **(SE 10)** la ubicación de los casos notificados de leishmaniosis es la **Zona de Éxito,** debido a que los casos notificados pasaron a semanas anteriores por la fecha de inicio de síntomas. ***(Ver Gráfico N° 11)***

Tabla N° 04. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniasis y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	39	49	54	60	65	17
IA x 100 Mil Hab.	22.64	28.54	31.26	34.93	37.81	9.88
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

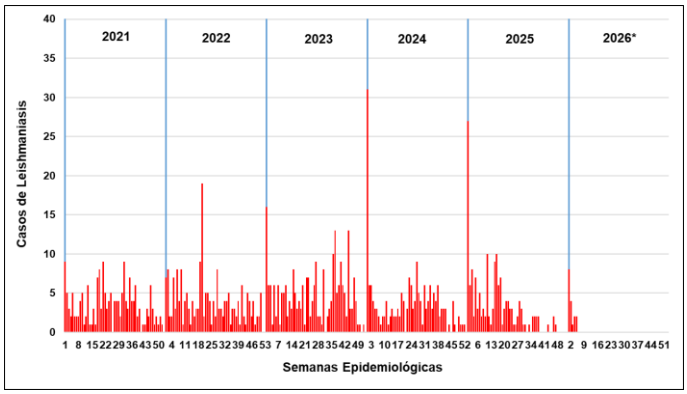
Tabla N° 05 y N° 06. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniosis, según Provincias y Distritos. Año 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
BONGARA	41	40	37	31	20	1	15	14	10	7	12	1
CHACHAPOYAS	56	60	97	73	48	11	9	14	17	27	16	11
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	69	81	77	50	56	2	9	15	22	15	24	2
RODRIGUEZ DE MENDOZA	15	20	33	33	33	3	6	6	5	11	13	3
UTCUBAMBA	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	**182**	**203**	**245**	**189**	**157**	**17**	**39**	**50**	**54**	**60**	**65**	**17**

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte SE. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
LA JALCA	21	17	29	35	12	6	3	5	4	13	4	6
TINGO	30	28	34	15	9	1	6	4	10	6	3	1
CHACHAPOYAS	11	28	27	13	16	0	1	6	2	4	4	0
JAZAN	27	21	22	14	10	0	10	9	5	3	6	0
OMIA	7	4	18	24	25	1	3	1	2	8	10	1
MAGDALENA	14	8	22	16	12	2	3	2	5	8	7	2
COCABAMBA	9	20	9	8	10	0	0	3	5	3	6	0
COLCAMAR	7	11	8	7	13	1	1	2	0	1	4	1
SANTO TOMAS	9	10	7	5	4	0	1	0	3	1	2	0
VALERA	6	12	9	5	1	1	1	4	4	2	1	1
CHURUJA	5	2	5	7	3	0	2	0	1	2	2	0
MARISCAL CASTILLA	6	1	3	5	1	3	1	0	1	0	0	3
SAN NICOLAS	0	6	4	3	4	1	0	1	2	0	1	1
LIMABAMBA	3	4	5	1	0	1	2	1	0	0	0	1
PISUQUIA	5	5	2	1	1	0	0	4	1	1	1	0
SAN FRANCISCO DE YESO	2	3	1	3	3	0	1	2	0	0	3	0
MILPUCC	4	4	2	1	1	0	1	3	1	1	0	0
CHILIQUIN	1	0	4	3	3	0	1	0	0	1	0	0
LEIMEBAMBA	2	3	5	0	1	0	0	1	2	0	0	0
INGUILPATA	1	1	3	2	2	0	0	0	0	0	1	0
CHIRIMOTO	0	0	3	3	3	0	0	0	0	1	2	0
LONYA CHICO	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0
SHIPASBAMBA	2	3	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0
LAMUD	0	1	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0
LUYA	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
MONTEVIDEO	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0
YAMBRASBAMBA	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0
FLORIDA	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0
SAN JUAN DE LOPECANCHA	2	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
MARIA	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
PROVIDENCIA	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
OCALLI	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
HUAMBO	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN ISIDRO DE MAINO	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CONILA	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
SANTA CATALINA	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CUISPES	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LONYA GRANDE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BAGUA GRANDE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN CRISTOBAL	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
SONCHE	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
CUMBA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUANCAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OCUMAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
BALSAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEVANTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BAGUA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LONGAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCHAMAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOLINOPAMPA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPORREDONDO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	**182**	**203**	**245**	**189**	**157**	**17**	**39**	**50**	**54**	**60**	**65**	**17**

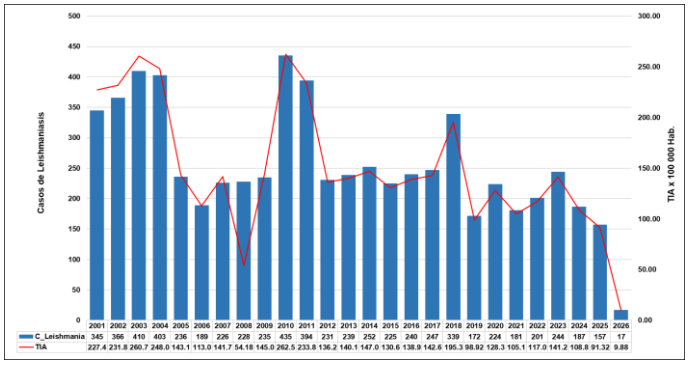
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 06. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de casos de Leishmaniosis. Años 2021 - 2026*



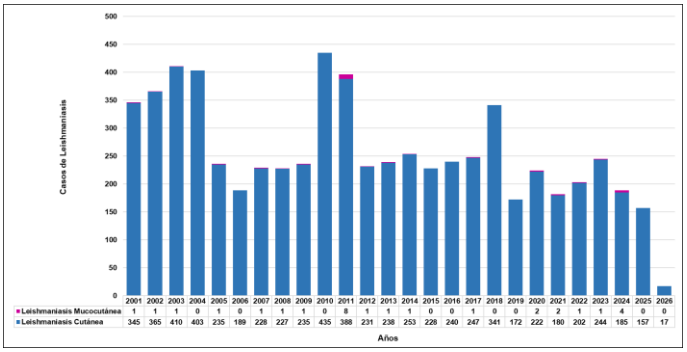
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 07. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Leishmaniasis y TIA. Años 2001 - 2026*



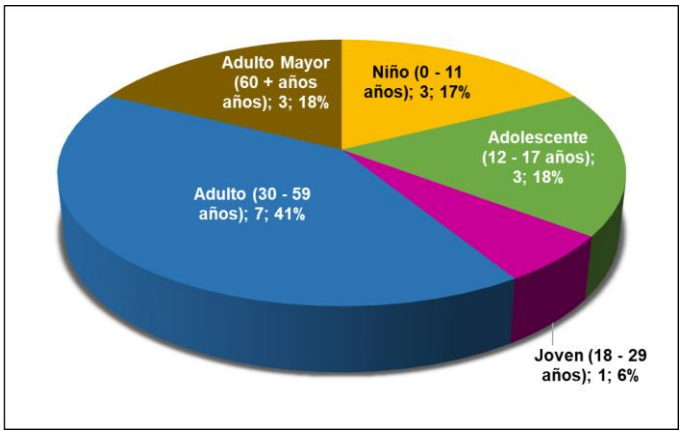
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 08. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniosis, según Tipo de Diagnóstico. Años 2001 - 2026*



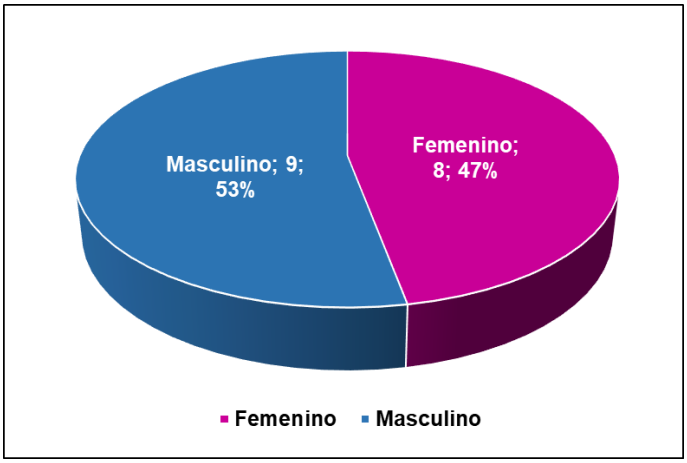
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 09. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Leishmaniosis, Según Curso de Vida. Año 2026*



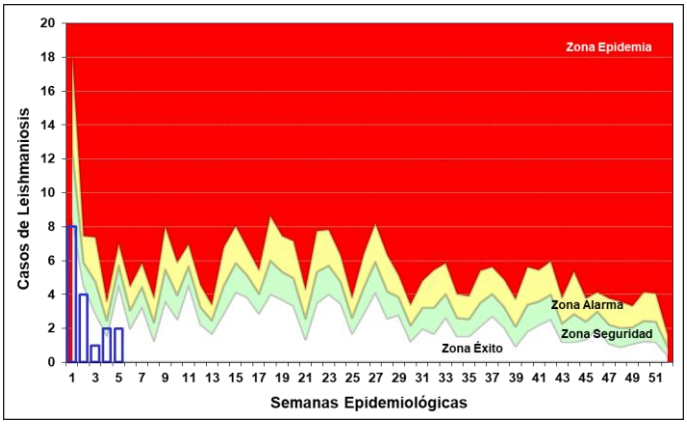
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10*.

Gráfico N° 10. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniosis, Según Sexo. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 11. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de Leishmaniosis. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Situación Epidemiológica de Dengue:

El dengue en Perú constituye un reto creciente para la salud pública, con episodios frecuentes de brotes que se ven intensificados por factores ambientales y la alta densidad poblacional en zonas urbanas, que promueven la expansión del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de esta enfermedad viral. En particular, el aumento de las temperaturas y los patrones de lluvia han agravado este problema. En muchas áreas afectadas la comunidad no se involucra adecuadamente en las iniciativas de control de la enfermedad. Por ello, es crucial dar prioridad al primer nivel de atención, donde se concentra la mayoría de los casos.

El dengue es una enfermedad febril aguda producida por el virus denominado con el mismo nombre. El virus dengue (VD) tiene cuatro serotipos. (DEN – 1, DEN – 2, DEN – 3 y DEN – 4), es transmitido al humano por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado.

En la Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 10)**, se ha notificado al sistema de vigilancia un total de **02 casos** de dengue **(C=02)**, siendo los **02 casos autóctonos** con una **IA 1.16 x 100 000 habitantes.** ***(Ver Tabla N° 07)***

La provincia que reporta el mayor número de casos de Dengue es la provincia de Bongará con el 100% (02/02); teniendo así que los **02 casos** autóctonos proceden de la provincia de Bongará; a nivel de distritos el más afectado por esta enfermedad es el distrito de Jazán (02 casos). ***(Ver Tabla N° 08 y N° 09)***

De acuerdo a la clasificación clínica tenemos que el 100% (02/02) de los casos corresponde a dengue sin signos de alarma y el 0% (00/02) a dengue con signos de alarma. ***(Ver Gráfico N° 12)***

El 50% de casos notificados son de sexo femenino (01/02) y el 50% restante son de sexo masculino (01/02). ***(Ver Gráfico N° 13)***

Según curso de vida, el grupo de edad más afectado para esta Semana Epidemiológica **(SE 10)** son los adultos de 30 – 59 Años con el 100% (02/02). ***(Ver Gráfico N° 14)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia una disminución de 60% (03 casos) en relación a los casos reportados para el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 15)***

Según el último quinquenio se evidencia que en el año 2023 se reportó la mayor cantidad de casos de dengue, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último quinquenio. ***(Ver Gráfico N° 16)***

Tabla N° 07. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	0	25	9	22	5	2
IA x 100 Mil Hab.	0.00	14.56	5.21	12.81	2.91	1.16
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 08. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	6	4	10	6	0	0	2	1	1	1	0
BONGARA	1	0	90	59	8	2	0	0	9	22	5	2
CHACHAPOYAS	26	29	13	0	0	0	0	25	0	0	0	0
CONDORCANQUI	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RODRIGUEZ DE MENDOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTCUBAMBA	5	7	11	14	5	0	0	1	4	3	0	0
Total general	33	43	118	84	20	2	1	29	14	26	6	2

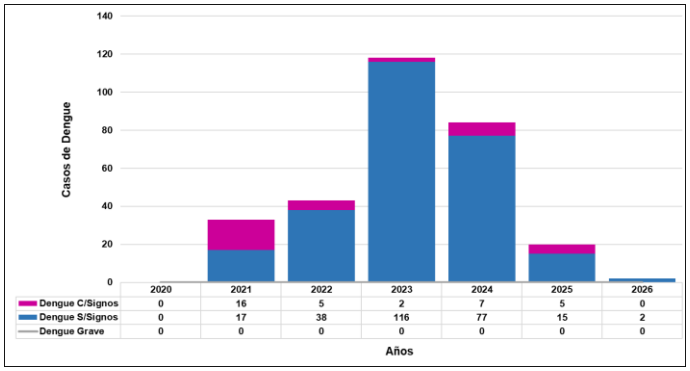
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 09. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
JAZAN	1	0	90	59	8	2	0	0	9	22	5	2
BALSAS	26	29	13	0	0	0	0	25	0	0	0	0
BAGUA GRANDE	0	7	9	6	4	0	0	1	4	0	0	0
BAGUA	0	4	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0
JAMALCA	5	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0
NIEVA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
IMAZA	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
CAJARURO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
COPALLIN	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
EL PARCO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
ARAMANGO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	33	43	118	84	20	2	1	29	14	26	6	2

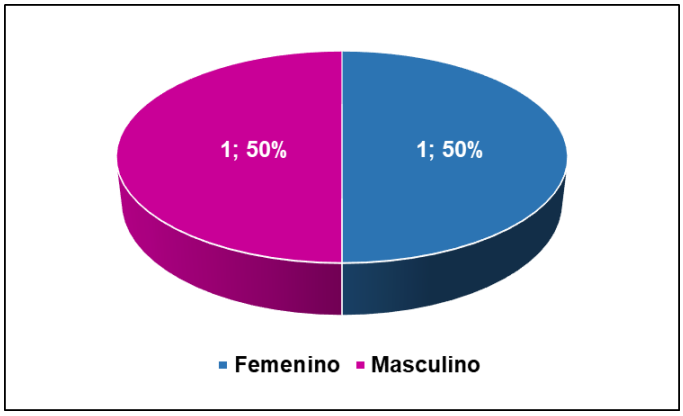
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 12. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue, Según Clasificación Clínica. Años 2020 - 2026*



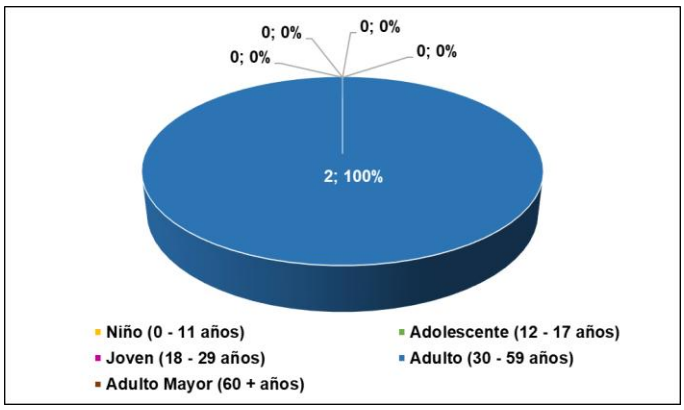
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 13. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue, Según Sexo. Año 2026*



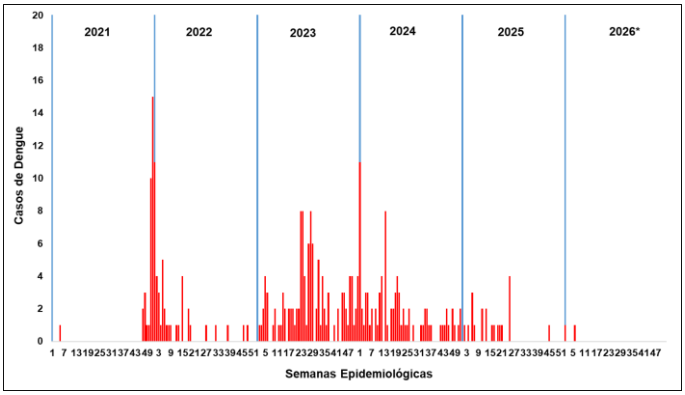
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 14. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Dengue, Según Curso de Vida. Año 2026*



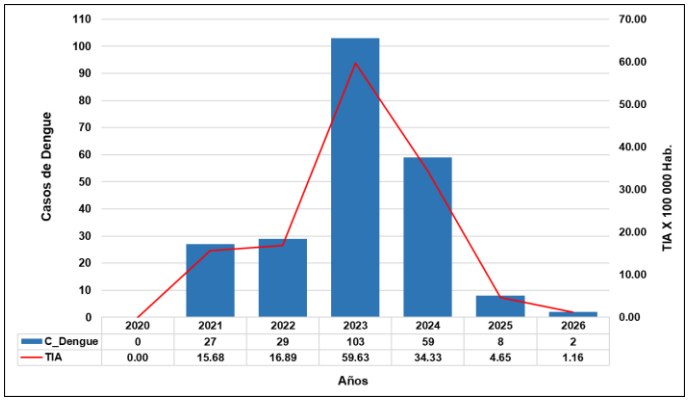
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 15. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de Casos de Dengue. Años 2021 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 16. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Dengue y TIA. Años 2020 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS:

Situación Epidemiológica de Leptospirosis:

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira.

La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.

Algunos de los factores de riesgo incluyen:

- Exposición ocupacional: agricultores, granjeros, trabajadores de los mataderos, cazadores (tramperos), veterinarios, leñadores, personas que trabajan en el alcantarillado, personas que trabajan en arrozales y personal militar.
- Actividades recreativas: nadar en aguas dulces, hacer canotaje, hacer kayak y ciclomontañismo en áreas cálidas.
- Exposición en el hogar: tener perros como mascotas, ganado doméstico, sistemas de recolección de agua de lluvia y roedores infectados.

Síntomas:

Los síntomas pueden tardar de 2 a 30 días (un promedio de 10 días) en aparecer y pueden incluir: Tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos y diarrea y escalofríos.

Los síntomas menos comunes incluyen: Dolor abdominal, ruidos pulmonares anormales, dolor de hueso, enrojecimiento sin fluido de la conjuntiva (superficie de la parte blanca de los ojos), inflamación de los ganglios linfáticos, agrandamiento del bazo o el hígado, dolores articulares, rigidez muscular, sensibilidad muscular, erupción cutánea y dolor de garganta.

Pruebas y exámenes:

Se analiza la sangre en busca anticuerpos contra la bacteria. Durante algunas fases de la enfermedad, las bacterias en sí pueden ser detectadas con un examen de reacción en cadena de polimerasa (RCP).

Otros exámenes que se pueden hacer son: Conteo sanguíneo completo (CSC), creatina cinasa, enzimas hepáticas, análisis de orina y hemocultivo.

Prevención:

Evite áreas de aguas estancadas o de inundaciones, especialmente en los climas tropicales. Si usted está expuesto a un área de alto riego, tome precauciones para evitar la infección. Utilice ropa, zapatos o botas de protección cuando se acerque a agua o suelo contaminado con orina animal. Puede tomar doxiciclina para disminuir el riesgo.

En la Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 10)**, se ha notificado al sistema de vigilancia un total de **02 casos** de Leptospirosis, siendo los **02 casos autóctonos** con una **IA 1.16 x 100 000 habitantes.** ***(Ver Tabla N° 10)***

Las provincias que reportan el mayor número de casos de Leptospiropsis es la provincia de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza con el 50% (01/02) cada provincia respectivamente; teniendo así que a nivel de distritos los afectados por esta enfermedad es Chachapoyas y Omia, reportando 01 caso cada uno. ***(Ver Tabla N° 11 y N° 12)***

El 50% de casos notificados son de sexo femenino (01/02) y el 50% restante son de sexo masculino (01/02). ***(Ver Gráfico N° 17)***

Según curso de vida, el grupo de edad más afectado para esta Semana Epidemiológica **(SE 10)** son los jóvenes 18 – 29 años y adultos de 30 – 59 Años con un 500% (01/02), respectivamente. ***(Ver Gráfico N° 18)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia una disminución de 83.33 % (10 casos) en relación a los casos reportados para el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 19)***

Según el último quinquenio se evidencia que en el año 2025 se reportó la mayor cantidad de casos de Leptospirosis, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último quinquenio. ***(Ver Gráfico N° 20)***

Tabla N° 10. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leptospirosis y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	0	0	0	0	12	2
IA x 100 Mil Hab.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	1.16
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 11. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leptospirosis, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	0	0	0	10	21	1	0	0	0	0	11	1
CHACHAPOYAS	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
RODRIGUEZ DE MENDOZA	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	0	0	0	18	24	2	0	0	0	0	12	2

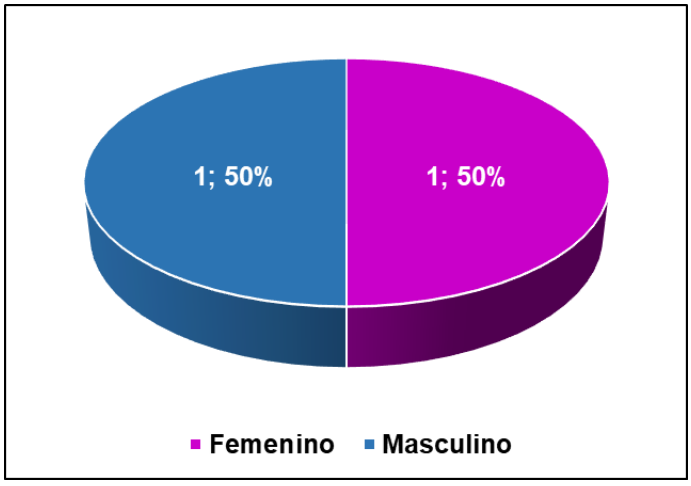
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 12. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leptospirosis, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
JAZAN	0	0	0	8	21	0	0	0	0	0	11	0
CHACHAPOYAS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
OMIA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
LONGAR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SHIPASBAMBA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONILA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
LA JALCA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
MARISCAL BENAVIDES	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
YAMBRASBAMBA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
FLORIDA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
IMAZA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN NICOLAS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PISUQUIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	0	0	0	18	24	2	0	0	0	0	12	2

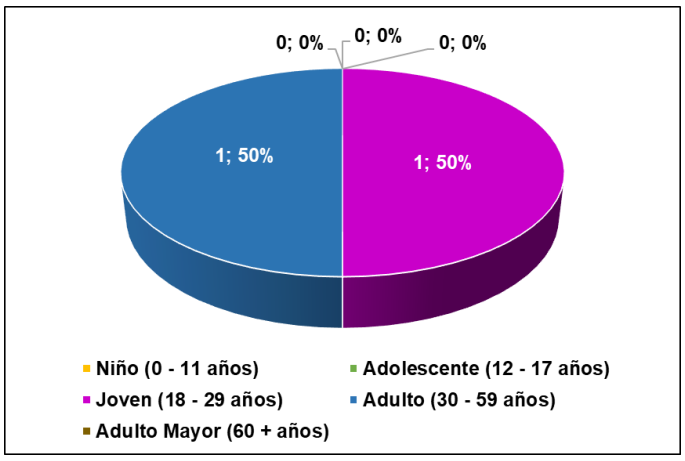
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 17. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leptospirosis, Según Sexo. Año 2026*



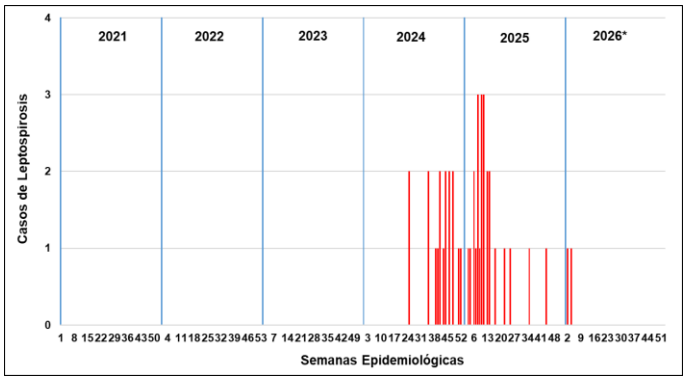
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 18. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Leptospirosis, Según Curso de Vida. Año 2026*



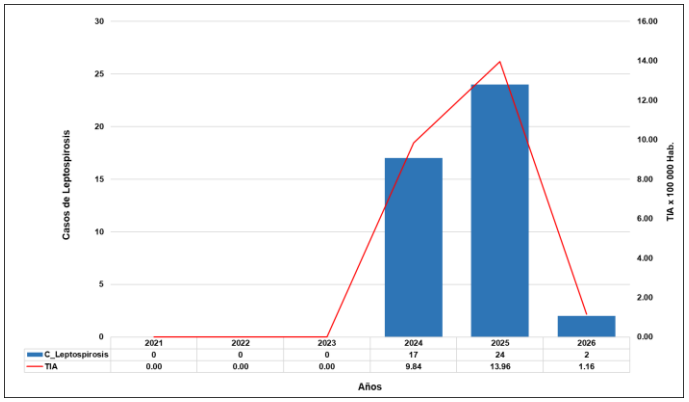
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 19. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de Casos de Leptospirosis. Años 2021 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 20. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Leptospirosis y TIA. Años 2020 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Situación Epidemiológica de Ofidismo:

Las enfermedades zoonóticas constituyen un grave problema de salud pública. Se estima que aproximadamente 61% de los microorganismos patógenos para el hombre y un 75% de los patógenos emergentes son de origen zoonótico.

En este contexto los sistemas de vigilancia en el mundo orientan sus esfuerzos al monitoreo de las tendencias y distribución de estas enfermedades en la población humana, así como en los animales reservorios y susceptibles.

Las poblaciones de mayor riesgo para daños zoonóticos, son principalmente aquellas que presentan niveles socioeconómicos bajos donde la pobreza, el hacinamiento, el limitado acceso a servicios básicos, entre otros factores, favorecen su transmisión. Asimismo, condiciones asociadas a los cambios climáticos y ambientales, la globalización del comercio y transporte de animales, favorecen el incremento del riesgo de transmisión de las zoonosis en el mundo.

La vigilancia de los daños de transmisión zoonótica en el Perú fue implementándose progresivamente a través de los años, es así que el ofidismo se vigila sistemáticamente desde el año 2000; sin embargo, se requiere estandarizar los procedimientos para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos, así como para la vigilancia, comunicación y notificación de epizootias.

Los accidentes por animales ponzoñosos son producidos por la exposición (mordedura, picadura, contacto) a serpientes, arácnidos y otros que al inocular sus toxinas en el organismo provocan una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a signos y síntomas, íntimamente relacionados con el género del animal agresor.

El **ofidismo** es un problema de singular importancia en las regiones rurales selváticas del país y en las zonas desérticas y semidesérticas de la costa norte y central.

Los accidentes producidos por serpientes venenosas en el Perú representan importantes pérdidas en el medio rural, sobre todo en áreas poco exploradas dentro de las que tenemos los nuevos asentamientos humanos en espacios rurales con fines agrícolas, exploraciones petrolíferas, mineras, forestales, pesca, caza turística.

El **ofidismo** es un accidente provocado por el veneno inoculado por la mordedura de una serpiente venenosa.

La Red de Salud Chachapoyas, realiza la Vigilancia Epidemiológica de este daño, a través de la notificación semanal como vigilancia de tipo

pasiva, notificando hasta la Semana Epidemiológica **(SE 10)** un total de **01 caso de mordedura** por serpiente, con una **IA 0.58 x 100 000 habitantes.** ***(Ver Tabla N° 13);*** procedente de la provincia de Rodríguez de Mendoza (01/01) del distrito de San Nicolás (01 caso). ***(Ver Tabla N° 14 y N° 15)***

Según curso de vida, el grupo de edad más afectado para esta Semana Epidemiológica **(SE 10)** son los jóvenes de 18 -29 Años con el 100% (01/01). ***(Ver Gráfico N° 21)***

El 100% de las víctimas de ofidismo son de sexo masculino (01/01) y el 0% (00/01) restante son de sexo femenino. ***(Ver Gráfico N° 22)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia que ha notificado la misma cantidad de casos en comparación a los casos reportados para el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 23)***

Según el último decenio los casos de mordedura por serpiente muestran un comportamiento oscilante, donde el mayor número de casos presentados fue en el 2021 con la notificación de 21 casos, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último decenio. ***(Ver Gráfico N° 24)***

Tabla N° 13. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Ofidismo y TIA. Años 2021- 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	3	2	0	2	1	1
IA x 100 Mil Hab.	1.74	1.16	0.00	1.16	0.58	0.58
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 14. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Ofidismo, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CHACHAPOYAS	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
RODRIGUEZ DE MENDOZA	18	7	6	9	7	1	2	1	0	1	1	1
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	21	8	8	11	9	1	0	2	0	2	1	1

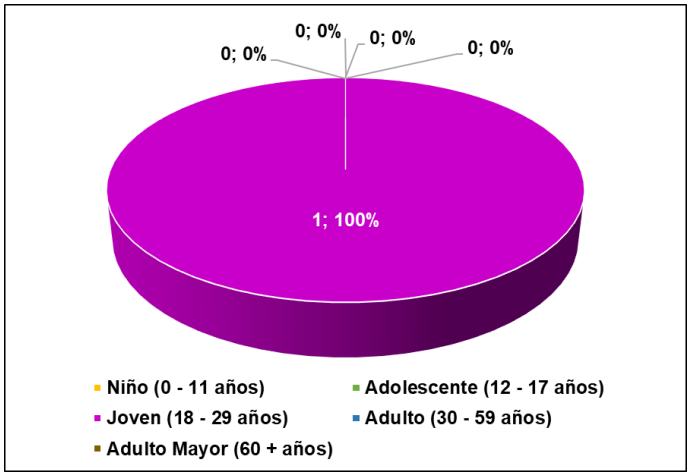
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 15. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Ofidismo, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

Distritos	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
SAN NICOLAS	3	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	1
OMIA	2	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
CHIRIMOTO	7	2	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
LIMABAMBA	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUAMBO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
LA JALCA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FLORIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARISCAL BENAVIDES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILPUCC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUQUIBAMBA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUISPES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEIMEBAMBA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YAMBRASBAMBA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SANTA CATALINA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
MOLINOPAMPA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PISUQUIA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total general	21	8	8	11	9	1	3	2	0	2	1	1

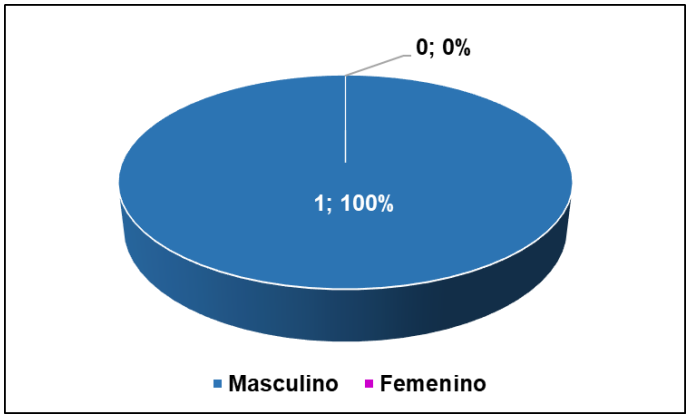
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 21. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Ofidismo, Según Curso de Vida. Año 2026*



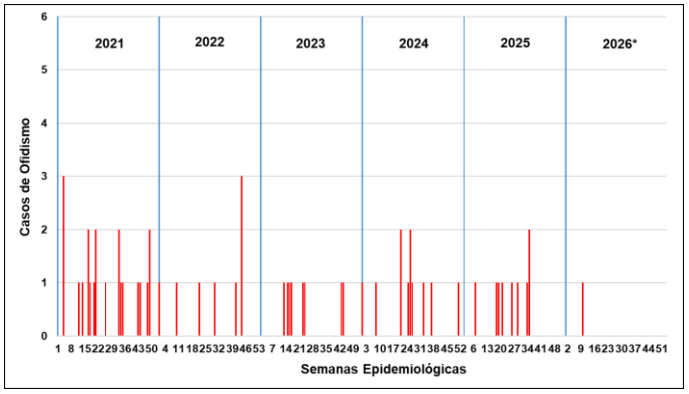
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 22. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Ofidismo, Según Sexo. Año 2026*



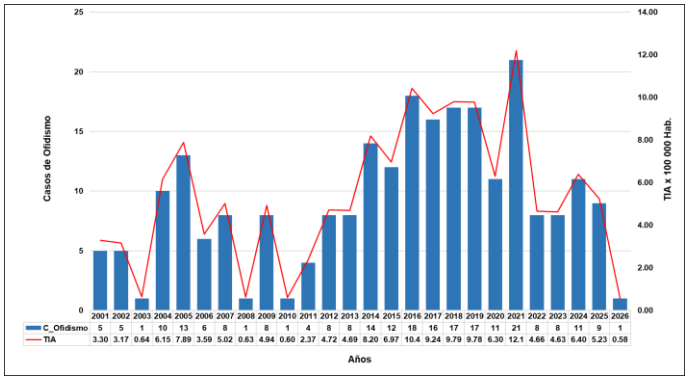
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 23. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de casos de Ofidismo. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 24. Red de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Ofidismo y TIA. Años 2001 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:

Situación Epidemiológica de Diabetes:

Caso de diabetes: Se denomina así a la persona de cualquier edad, con diagnóstico de diabetes por un profesional médico en base a criterios clínicos (poliuria, polifagia y polidipsia), con test de glicemia en plasma tomada en ayunas de 126 mg/dL o superior, o con un test de glicemia en cualquier hora del día de 200mg/dl o superior. Aquel que fue diagnosticado previamente como diabético y recibe tratamiento hipoglicemiante, aunque tenga un test de glicemia menor de 126 mg/dL, se considera un caso de diabetes.

Caso nuevo o incidente: Se refiere a la persona con diabetes que es diagnosticado por primera vez, y que anteriormente desconocía su condición de diabético. No tiene historia previa de tratamiento para la diabetes.

Caso prevalente: Se refiere a la persona con diabetes que ha sido diagnosticado previamente por un profesional médico en un servicio de salud, mediante un test de glicemia o una prueba de tolerancia a la glucosa, sin importar que el paciente haya iniciado o no el tratamiento correspondiente.

Tabla 2. Categorías de valores de glicemia en ayunas y del Test de tolerancia a la glucosa.

Diagnóstico metabólico	Glucosa Plasmática	
	Ayunas	2 horas post carga de Glucosa
Normal	<100	<140
GAA	100 a 125	<140
TGA	<100	140 a 199
GAA+TGA	100 a 125	140 a 199
Diabetes	≥126	≥200

Tomado de ALAD.

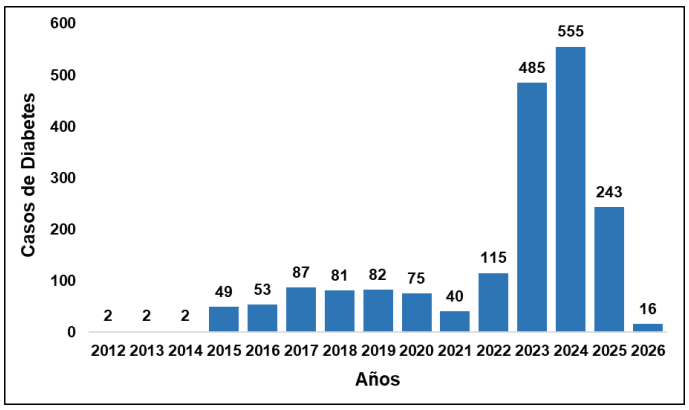
En la Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 10)**, se ha notificado al sistema de vigilancia un total de **16 casos** de Diabetes Mellitus. Del total de casos reportados el 75% (12/16) corresponden a casos prevalentes, mientras que el 25% (04/16) son casos nuevos. ***(Ver Gráfico N° 25 y N° 26)***

El 94% (15/16) de los casos registrados de diabetes corresponde a diabetes tipo 2, el 6% (01/16) a diabetes tipo 1 y el 0 (00/16) % a diabetes gestacional. En relación al tipo de caso, se tiene que 11 casos de los casos prevalentes fueron diabetes tipo 2 y 01 caso diabetes tipo 1, y 04 casos corresponde a casos nuevos en diabetes tipo 2. ***(Ver Gráfico N° 27 y N° 28)***

En la Red Integrada de Salud Chachapoyas, hasta la SE 10-2026*, se observa que la mayoría de los casos de diabetes se concentran en los grupos de edad 30 - 59 años a más (09/16) y 60 años a más (06/16). Además, se destaca que el 62% (10/16) de los casos registrados corresponden a mujeres, mientras que el 38% (06/16) son varones. Estos datos indican que la prevalencia de la diabetes es especialmente alta en la etapa de adulto y adulto mayor y de sexo femenino. ***(Ver Tabla N° 16 y Gráfico N° 29)***

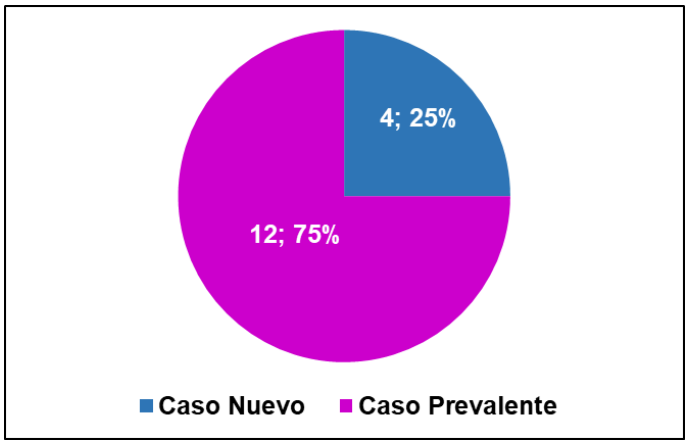
El 37% (06/16) de casos notificados presentan alguna comorbilidad y el 63% (10/16) de casos no presenta comorbilidad. Las comorbilidades reportadas con mayor frecuencia fueron: la hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia. ***(Ver Gráfico N° 30 y N° 31)***

Gráfico N° 25. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Diabetes. Años 2012 – 2026*



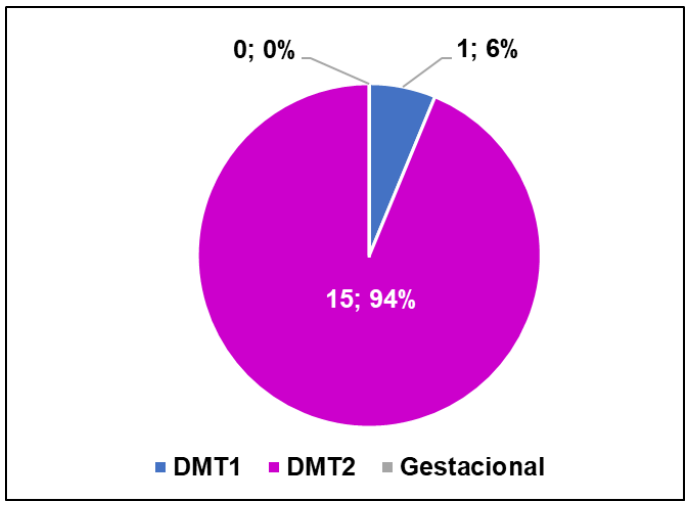
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 26. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Tipo de Caso. Año 2026*



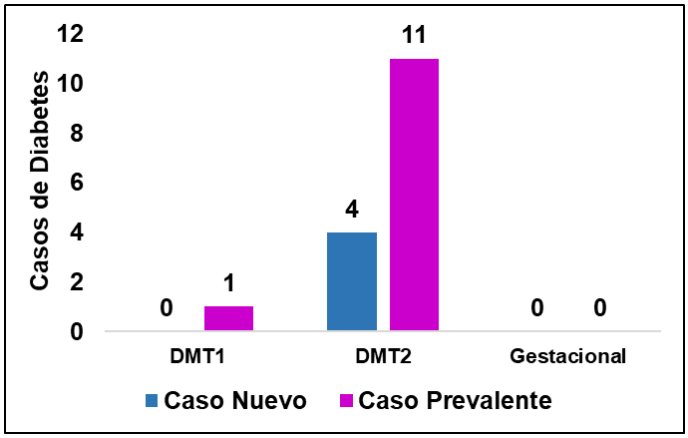
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 27. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Tipo de Diabetes. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 28. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Tipo de Caso y Tipo de Diabetes. Año 2026*



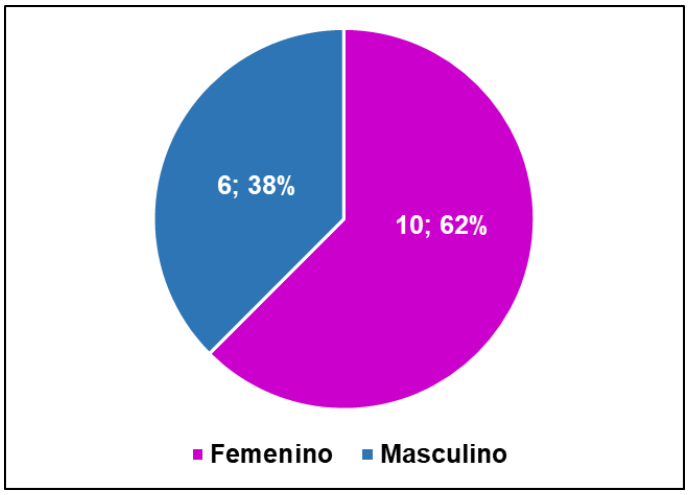
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 16. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Curso de Vida y Sexo. Año 2026*

Curso de Vida	Total	%	Sexo			
			Femenino Cant. Casos	% Curso de Vida	Masculino Cant. Casos	% Curso de Vida
Niño (0 - 11 años)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(Adolescente) 12 - 17 años	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Joven (18 - 29 años)	1	6.25	0	0.00	1	6.25
Adulto (30 - 59 años)	9	56.25	6	60.00	3	56.25
Adulto mayor (60 + años)	6	37.50	4	40.00	2	37.50
Total	16	100.00	10	100.00	6	100.00

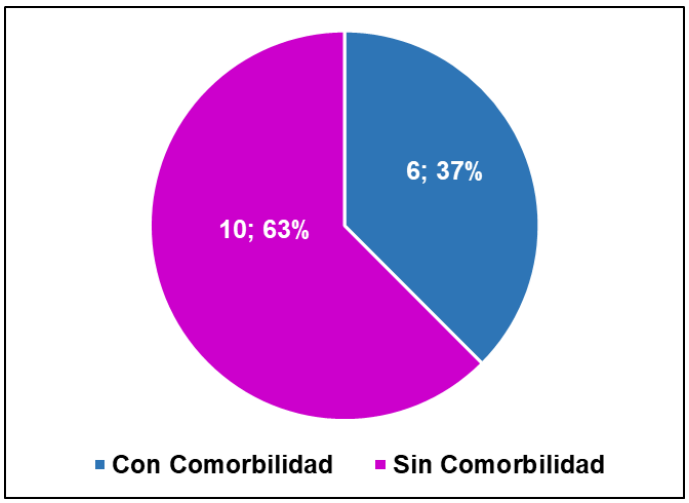
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 29. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Sexo. Año 2026*



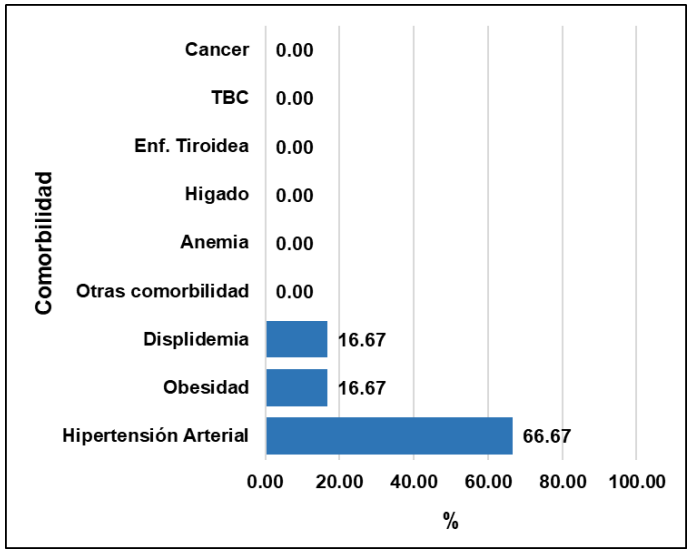
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 30. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, con alguna Comorbilidad. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 31. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Tipo de Comorbilidad. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

OTRAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

Situación Epidemiológica de Riesgo de Exposición e Intoxicación Por Metales Pesados, Metaloides, Plaguicidas y Otras Sustancias Toxicas:

Los **plaguicidas** son sustancias ampliamente utilizadas en el mundo para el control de diferentes agentes, entre los que se encuentran insectos, artrópodos, animales transmisores de enfermedades, hongos y especies vegetales. Estos productos se utilizan en la agricultura (control de insectos y malezas); en la ganadería (control de parásitos); en el control de roedores y vectores transmisores de enfermedades como los mosquitos.

Son sustancias comercializadas en todo el mundo y utilizadas tanto de forma industrial como doméstica. En algunos casos, el contacto con plaguicidas tiene como consecuencia las intoxicaciones que se dan bien sea por uso inapropiado, de forma accidental (niños, por ejemplo) o incluso de manera delictiva y homicida.

Los **plaguicidas** se pueden clasificar de acuerdo con su uso, su estructura química o su toxicidad; sin embargo, la orientación terapéutica para los casos de intoxicación se enfoca en su estructura química. Todos los plaguicidas no se manejan de la misma manera, ni tienen las mismas implicaciones clínicas; algunos son extremadamente tóxicos y no se dispone de un antídoto específico para su manejo, otros son de baja toxicidad y son escasos los efectos tóxicos en el organismo. Es importante comprender la implicación que tienen las intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP) para su identificación y manejo.

Tóxico es toda sustancia capaz de producir algún daño en la estructura o función de un organismo afectándolo de forma local o sistémica, e intoxicación se entiende como un conjunto de alteraciones fisiológicas o anatomopatológicas producidas por la absorción de tóxicos, con diferente grado de gravedad clínica, la cual depende de diferentes variables de la sustancia y del individuo.

En el país se ha presentado un aumento importante en el uso de plaguicidas por la expansión de la ganadería, la agricultura y el uso en cultivos como el algodón, el plátano, la caña o las flores entre otros, o en el control de malezas, parásitos, roedores y vectores fundamentalmente; también se ha presentado un aumento en la cantidad de casos de intoxicación, los cuales se pueden clasificar de diferentes maneras.

Las **intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP)**, son una de las principales causas de muerte por intoxicaciones en el mundo, sin embargo, el sub-registro de este tipo de eventos aún es importante. Cada año, nuevos productos para el control de plagas y malezas salen al mercado y su uso se formula específicamente para cada producto o para múltiples productos según los requerimientos de quien los utilice.

En el mundo, la creciente tendencia de consumo de plaguicidas se refleja en las estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo de estas sustancias y de las intoxicaciones que causan.

En la Red de Salud Chachapoyas la vigilancia se está implementando de manera progresiva, teniendo en cuenta los distritos o lugares con mayor riesgo para ambas intoxicaciones; mayormente se notifican casos de **intoxicación por plaguicidas,** notificándose hasta la Semana Epidemiológica **(SE 10) 02 casos,** con una **IA 1.16 x 100 000 habitantes.** No reportándose defunciones hasta la fecha. ***(Ver Tabla N° 14)***

Comparando los casos por provincias, Chachapoyas es la que registra más casos en un 100% (02/02); y a nivel de distritos, La Jalca registra el 100% de casos (02/02). ***(Ver Tabla N° 15 y N° 16)***

Según el curso de vida más afectado para esta Semana Epidemiológica **(SE 10)** son los jóvenes de 18 – 29 Años con un 50% (01/02), asimismo los adultos de 30 – 59 Años con el 50% (01/02) restante, del total de casos. ***(Ver Gráfico N° 32)***

Con respecto al género el 100% (02/02) fue masculino y el 0% (00/00) femenino. ***(Ver Gráfico N° 33)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia un aumento del 50% (01 caso) en comparación a los casos reportados para el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 34)***

Según el último decenio los casos de intoxicación por plaguicidas muestran un comportamiento oscilante, donde el mayor número de casos presentados fue en el año 2017 con la notificación de 23 casos, mostrando una mayor sensibilidad en su notificación; asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último decenio. ***(Ver Gráfico N° 35)***

Tabla N° 17. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Intoxicación por Plaguicidas y TIA. Años 2021 – 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	2	0	4	1	1	2
IA x 100 Mil Hab.	1.16	0.00	2.32	0.58	0.58	1.16
Defunciones	2	0	1	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 18. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Intoxicación por Plaguicidas, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CHACHAPOYAS	1	4	6	7	7	2	0	0	4	1	1	2
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	3	3	4	0	6	0	2	0	0	0	0	0
RODRIGUEZ DE MENDOZA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	4	10	11	7	14	2	2	0	4	1	1	2

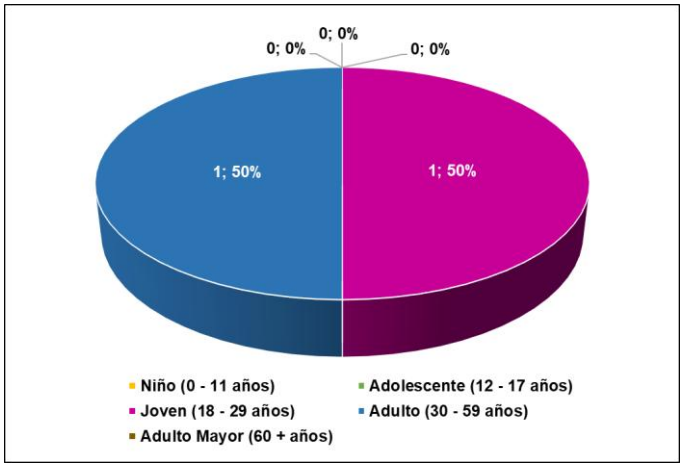
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 19. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Intoxicación por Plaguicidas, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
CHACHAPOYAS	0	1	3	3	5	0	0	0	1	0	1	0
LEIMEBAMBA	0	0	1	3	1	0	0	0	1	1	0	0
LA JALCA	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
MOLINOPAMPA	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
PISUQUIA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TRITA	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
SAN FRANCISCO DE YESO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCUMAL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
TINGO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JAZAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VALERA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTEVIDEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN JERONIMO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CUISPES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUQUIBAMBA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIRIMOTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BALSAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LONYA CHICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHILIQUIN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
COCABAMBA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPORREDONDO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLORIDA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCALLI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LEVANTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Total general	4	10	11	7	14	2	2	0	4	1	1	2

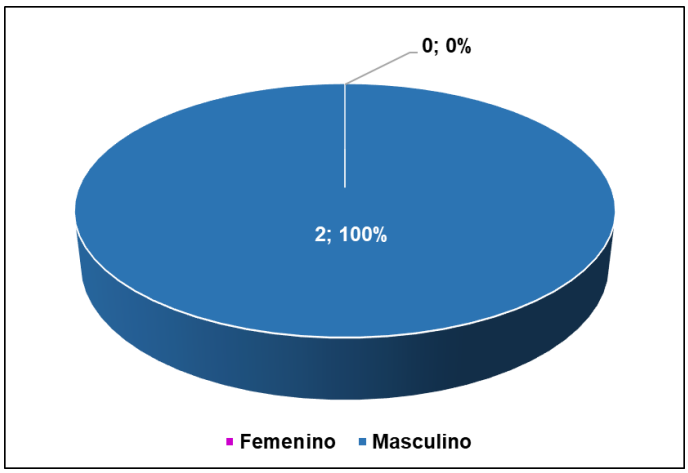
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 32. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Intoxicación por Plaguicidas, Según Curso de Vida. Año 2026*



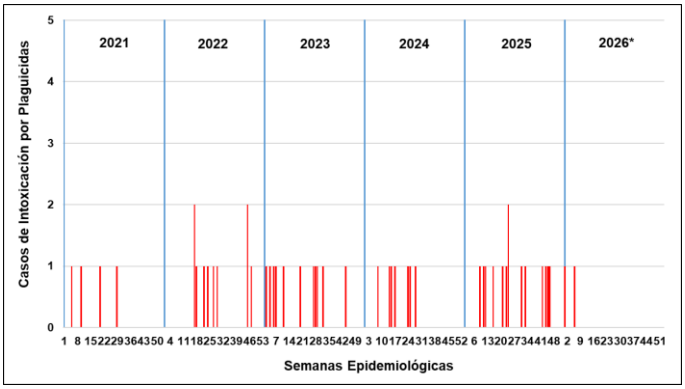
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 33. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Intoxicación por Plaguicidas, Según Sexo. Año 2024*



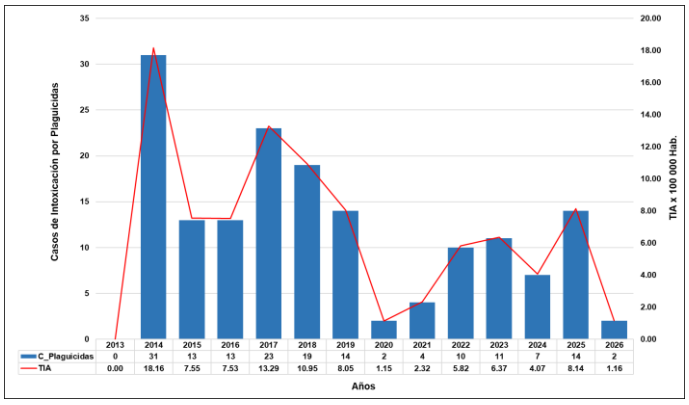
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 34. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de Casos de Intoxicación por Plaguicidas. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 35. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Intoxicación por Plaguicidas y TIA. Años 2013 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN LA RED INTEGRADA DE SALUD CHACHAPOYAS HASTA LA SE 10 – 2026*

Las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo una causa importante de morbilidad en la niñez en nuestra región, además son enfermedades prevenibles relacionadas al menor acceso a servicio de agua potable, menor acceso a eliminación adecuada de excretas, así como a la práctica de hábitos inadecuados de higiene.

La Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 10)** del año 2026, ha notificado un total de **1659 episodios** de EDA; teniendo **1656 episodios autóctonos**, de los cuales, el 29.47% corresponde a menores de 5 años con una razón de 41.67 episodios por cada 1000 menores de 5 años, mientras que el 70.53% afectó a personas de 5 años o más con una razón de 7.28 episodios por cada 1000 habitantes de 5 años a más. Además, se reportaron 31 hospitalizaciones por EDA con una razón de 1.87 hospitalizados por cada 100 episodios. Esta razón fue mayor en el grupo de menores de 5 años en comparación con el grupo de 5 años o más. En cuanto a las defunciones, en el año 2026 se registró una defunción. ***(VerTabla N° 20)***

El promedio total de episodios de EDA notificados por SE en el 2026, hasta la SE 10 fue de 166, cifra que representa una disminución en 10.27% en comparación con el año 2025, cuando se registraron 185 episodios por SE. A nivel de la Red de Salud Chachapoyas, se observa una tendencia oscilante de los episodios de EDA desde el inicio del 2026 hasta la SE 10 y un incremento significativo en la notificación en la semana 01. ***(Ver Gráfico N° 36 y N° 37)***

La razón de episodios de EDA en el 2026 fue de 9.62 episodios por cada 1000 habitantes, presentándose la mayor cantidad de episodios en las provincias de Chachapoyas y Luya. ***(VerTabla N° 21 y N° 22)***

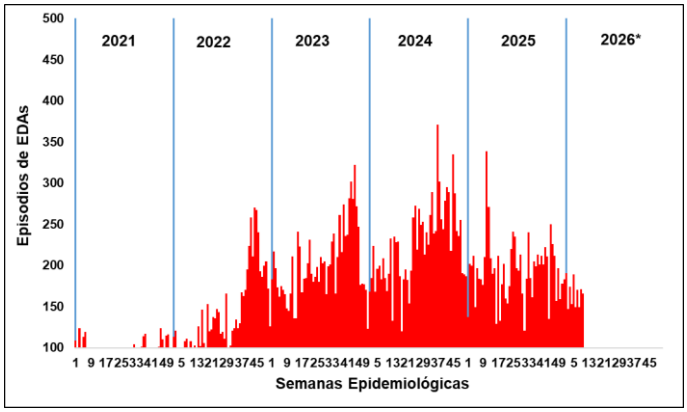
Según el canal endémico, los episodios de EDAs se encuentran en la **Zona de Seguridad;** zona que representa el 40% (04/10) del total de semanas epidemiológicas reportadas; de la misma manera los episodios de EDAs acuosas también se encuentran en la **Zona de Seguridad**, a diferencia los episodios de EDAs disentéricas para esta SE se encuentran en la **Zona de Éxito.** (***Ver Gráfico N° 38, N° 39 y N° 40***)

Tabla N° 20: Red Integrada de Salud Chachapoyas: Indicadores de las Enfermedades Diarreicas Agudas por Grupos de Edad. Años 2024 – 2026*

INDICADOR	EDAD	2024	2025	2026*
EPISODIOS	< 5 Años	3317	2772	488
	> 5 Años	8384	7461	1168
	Total	**11701**	**10233**	**1656**
	Acuosa	11608	10184	1653
	Disenterica	93	49	3
Incidencia Acumulada x 1000 Hab	< 5 Años	254.90	217.41	41.67
	> 5 Años	52.78	46.87	7.28
	Total	**68.08**	**59.52**	**9.62**
Hospitalizaciones	< 5 Años	28	18	12
	> 5 Años	93	27	19
	Total	**121**	**45**	**31**
Tasa de Hospitalizaciones x 100 episodios	< 5 Años	0.84	0.65	2.46
	> 5 Años	1.11	0.36	1.63
	Total	**1.03**	**0.44**	**1.87**
Defunciones	< 5 Años	0	0	0
	> 5 Años	0	0	1
	Total	**0**	**0**	**1**
Tasa de mortalidad x 100 episodios	< 5 Años	0.00	0.00	0.00
	> 5 Años	0.00	0.00	0.09
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.06**

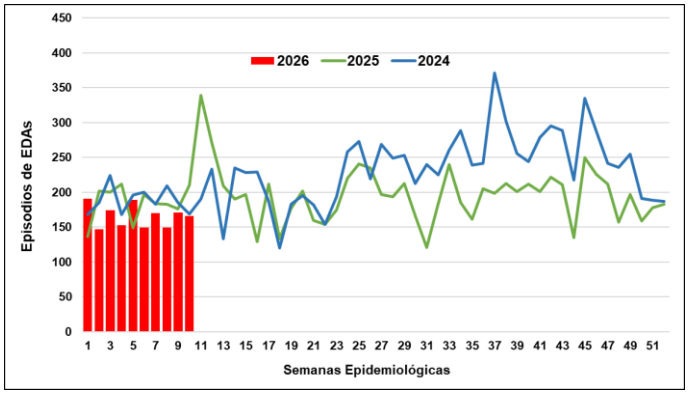
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 36. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 37. Red de Salud Chachapoyas: Episodios de las Enfermedades Diarreicas Agudas por Semana Epidemiológica. Años 2024- 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 21. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas y TIA. Años 2021 – 2026*

Años	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Episodios	980	1025	1728	1876	1850	1656
Incidencia por Mil Hab.	5.69	5.97	10.00	10.91	10.76	9.62
Defunciones	0	0	0	0	0	1

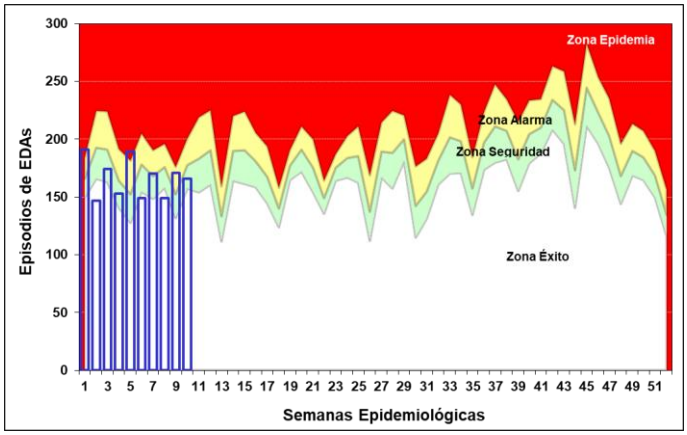
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 22: Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Años 2021 – 2026*

Provincias	AÑOS						Corte S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	602	919	1223	1535	1614	240	106	137	201	260	357	240
CHACHAPOYAS	1512	3136	4786	5265	4163	773	340	426	763	857	754	773
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	1714	2220	2991	3453	3157	435	392	307	563	492	514	435
RODRIGUEZ DE MENDOZA	645	1096	1526	1448	1299	208	142	155	201	267	225	208
UTCUBAMBA	28	58	7	56	3	3	4	1	7	11	0	3
Total general	4501	7432	10533	11757	10236	1659	984	1026	1735	1887	1850	1659

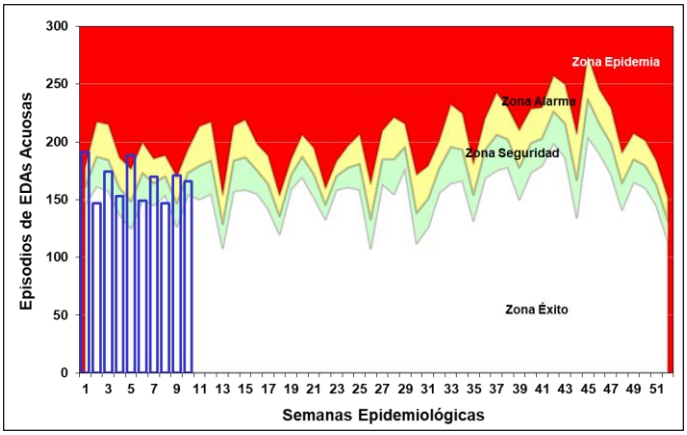
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 38. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Año 2026*



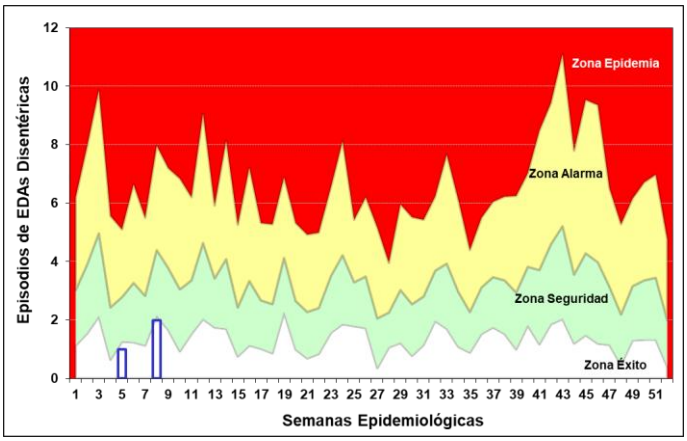
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 39. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de las Enfermedades Diarreicas Agudas Acuosas. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 40. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de las Enfermedades Diarreicas Agudas Disentéricas. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA), NEUMONÍAS Y SOB (ASMA) EN LA RED INTEGRADA DE SALUD CHACHAPOYAS HASTA LA SE 10 - 2026*

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves. Existen factores que favorecen una mayor incidencia de IRA como: bajo peso al nacer, malnutrición (principalmente en niños), la polución atmosférica, hacinamiento en el hogar, los bajos niveles de inmunización y el nivel de pobreza, son condiciones que se encuentran aún latentes en parte de nuestro país.

El Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, realiza la vigilancia epidemiológica de la tendencia y el comportamiento de las IRA desde 1999, a través de la Directiva N° 001- DGSP/SUBPCIRA-02/99, la Directiva sanitaria N° 046- MINSA/DGE-V.01 con R.M. N° 506-2012/MINSA del 18 de junio de 2012, que es actualizada con la Directiva Sanitaria N° 061-MINSA/DGE-V.01 con R.M. N° 1024-2014/MINSA del 31 de Diciembre de 2014, que norma la notificación de las IRA, neumonías y defunciones por neumonía, con prioridad en los grupos de riesgo: menores de 5 años y de 60 años a más a nivel nacional, en forma colectiva.

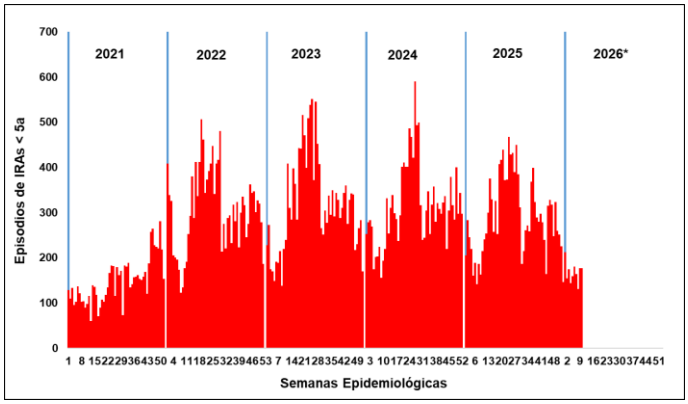
La coordinación de Epidemiología de la Red de Salud Chachapoyas, es responsable de la vigilancia epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y Neumonías, dicha notificación se realizan de forma semanal y consolidada, los datos son recolectados según grupo de edad, semana epidemiológica y distrito de procedencia. La notificación de las defunciones por neumonía en menores de 5 años es individual y consolidada, con el objetivo de conocer mejor los factores de riesgo para la orientación de las intervenciones preventivas.

En lo que va del año 2026, desde la semana epidemiológica SE 01 hasta la SE 10, se observa una tendencia oscilante de episodios de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años y una leve disminución las últimas 09 semanas notificadas. **(Ver Gráfico N° 41 y N° 42)** Notificándose un total de 1673 episodios de IRA, siendo los 1673 episodios de IRA autóctonos, con una razón de 1428.69 episodios por cada 10 000 menores de 5 años. **(Tabla N° 23)**

Por otro lado, se observa que la mayor cantidad de episodios de IRA provienen de las provincias de Chachapoyas y Luya de la jurisdicción de la Red Integrada de Salud Chachapoyas. ***(Ver Tabla N° 24)***

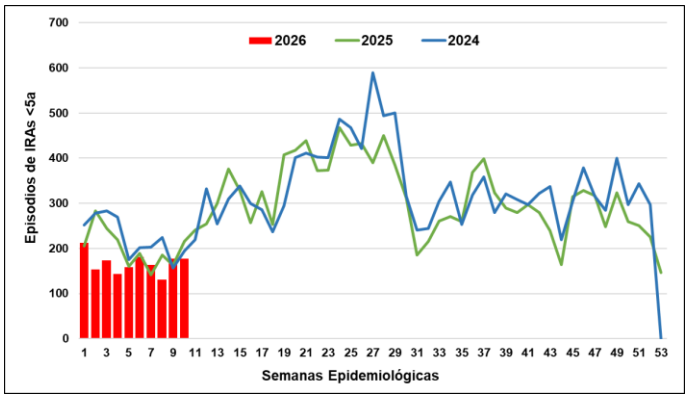
Según el canal endémico, los episodios de IRA se encuentran en la **Zona de Éxito;** zona que representa el 80% (08/10) del total de semanas epidemiológicas reportadas. ***(Ver Gráfico N° 43)***

Gráfico N° 41. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de las Infecciones Respiratorias Agudas en Niños < 5 Años. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 42. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios de las Infecciones Respiratorias Agudas en Niños < 5 Años por Semana Epidemiológica. Años 2024- 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 23. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios de Infecciones Respiratorias Agudas y TIA. Años 2021 – 2026*

Años	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Episodios	1120	2281	1937	2234	2007	1673
TIA x 10 Mil Hab.	725.86	1589.77	1451.81	1716.74	1574.12	1428.69

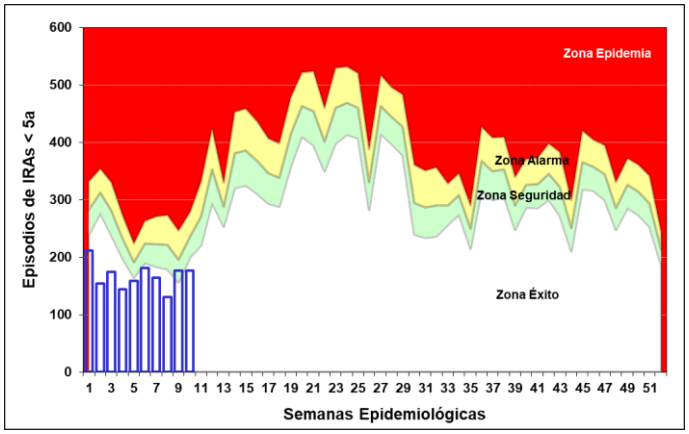
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Tabla N° 24: Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios, Razón, Defunciones y Letalidad de Infecciones Respiratorias Agudas en Niños < 5 Años, Según Provincias. Año 2026*

Provincias	AÑOS						Corte S.E. 10*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	1232	2766	2714	2563	2541	260	142	381	351	320	344	260
CHACHAPOYAS	2157	5342	5629	5390	4822	509	310	768	604	766	593	509
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	3099	5286	5112	5941	5727	662	456	826	619	759	746	662
RODRIGUEZ DE MENDOZA	1226	2584	3213	2566	2367	242	212	306	363	389	324	242
UTCUBAMBA	15	43	12	6	4	0	3	0	11	2	0	0
Total general	7729	16035	16680	16466	15461	1673	1123	2281	1948	2236	2007	1673

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

Gráfico N° 43. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de las Infecciones Respiratorias Agudas en Niños < 5 Años. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 10.

INDICADORES DE MONITOREO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 10 - AÑO 2026*

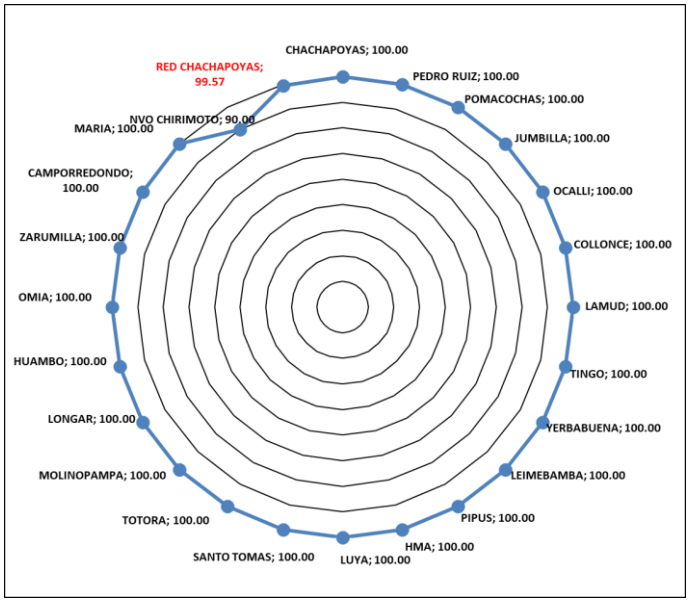
Los indicadores de monitoreo contribuyen a mejorar la información semanal para que esta sea oportuna y de calidad y así el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, de la Red de Salud Chachapoyas tenga un procesamiento y análisis de datos válidos para la toma de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia en salud pública. Teniendo como criterios de calificación para los Indicadores de Monitoreo: **DEBIL, REGULAR, BUENO Y OPTIMO.**

Estratos Nacional					
OPORTUNIDAD	COBERTURA	CALIDAD DEL DATO	RETROALIMENTACIÓN	Puntaje Total	
1. 100%	1. 100%	1. 95 - 100%	1. 90 - 100%	A. 90% - 100%	Óptimo
2. 95 - 99.9%	2. 80 - 99.9%	2. 90 - 94.9%	2. 80 - 89.9%	B. 80% - 90%	Bueno
3. 90 - 94.9%	3. 60 - 79.9%	3. 85 - 89.9%	3. 70 - 79.9%	C. 70% - 80%	Regular
4. Menos de 90%	4. Menos de 60%	4. Menos de 85%	4. Menos de 70%	D. Menos de 70%	Débil

Indicador de Oportunidad:

En el indicador de Oportunidad a la SE 10 del año 2026, la Red Integrada de Salud Chachapoyas obtiene una calificación BUENO (99.57%), de la misma manera las 21 Microrredes y el Hospital María Auxiliadora obtuvieron una calificación ÓPTIMO (100%); sin embargo, la Microrred Nuevo Chirimoto obtuvo una calificación REGULAR (90.00%). ***(Ver Gráfico N° 44)***

Gráfico N° 44. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Oportunidad de la Notificación. Año 2026*

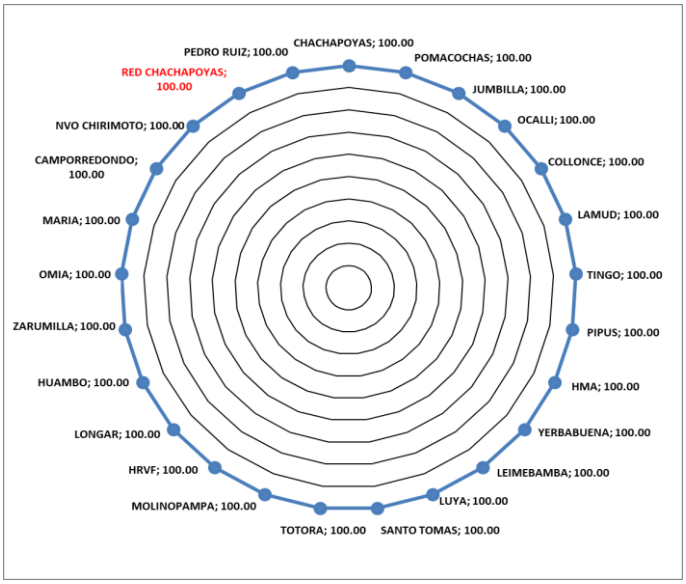


Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 10.

Indicador de Cobertura:

En el indicador de Cobertura a la SE 10 del año 2026, la Red Integrada de Salud Chachapoyas obtiene una calificación ÓPTIMO (100%), de la misma manera las 22 Microrredes y el Hospital María Auxiliadora obtuvieron una calificación ÓPTIMO (100%). ***(Ver Gráfico N° 45)***

Gráfico N° 45. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Cobertura de la Notificación. Año 2026*



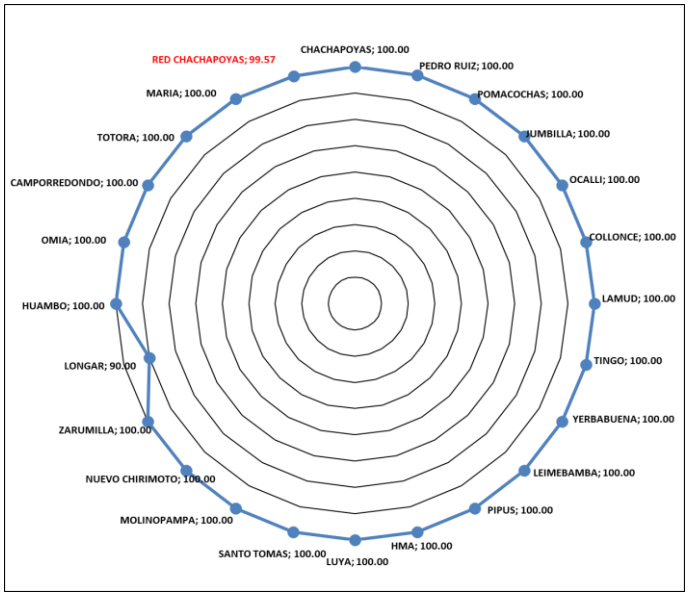
Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 10.

Indicador de Calidad del Dato:

En el indicador de Calidad del Dato a la SE 10 del año 2026, la Red Integrada de Salud Chachapoyas obtiene una calificación ÓPTIMO (99.57%), de la misma manera 21 Microrredes y el

Hospital María Auxiliadora obtuvieron una calificación ÓPTIMO (100%); sin embargo, la Microrred Longar obtuvo una calificación BUENO (90.00%). ***(Ver Gráfico N° 46)***

Gráfico N° 46. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Calidad del Dato. Año 2026*

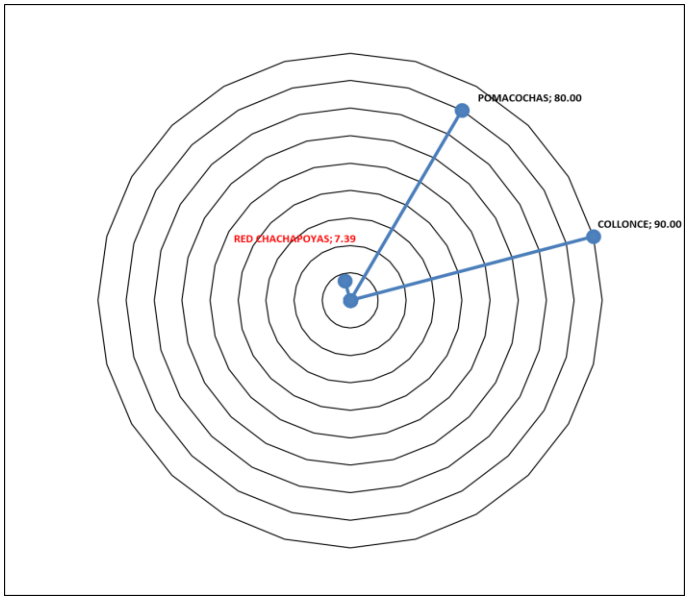


Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 10.

Indicador de Retroalimentación:

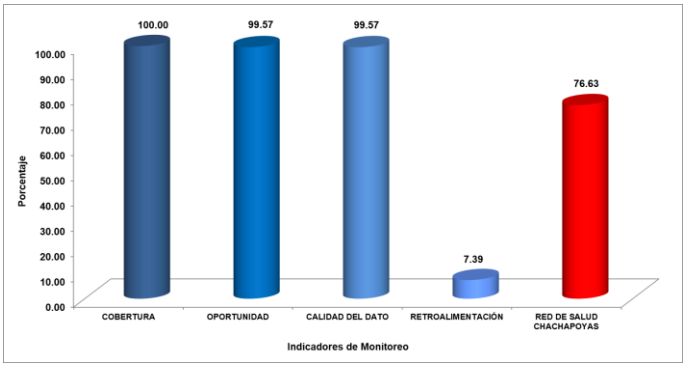
En el indicador de Retroalimentación a la SE 10 del año 2026, la Red Integrada de Salud Chachapoyas obtiene una calificación DÉBIL (<70%). La Microrred Collonce obtuvo una calificación ÓPTIMO (100%), la Microrred Pomacochas obtuvo una calificación BUENO (88.89%), sin embargo, las 20 Microrredes y el Hospital María Auxiliadora obtuvieron una calificación DÉBIL (<70%). ***(Ver Gráfico N° 47)***

Gráfico N° 47. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Retroalimentación. Año 2026*



Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 10.

Gráfico N° 48. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Monitoreo de Indicadores del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Año 2026*



Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 10.